CNAM — TITRE RNCP PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL (NIVEAU 7)

PST106 · Séance 6 : Clinique du Collectif, Catachrèse & Dérives de l'Individualisation

Restitution d'ateliers cliniques : cas réels (assistante maternelle, crèche en sous-effectif, Carrefour) et renouvellement du genre professionnel

Enseignante : Mme Jessica ROUSSAN (Maîtresse de conférences / Psychosociologie & Clinique de l'activité)

Date du cours : Jeudi 12 Novembre 2026 (18h00 – 20h08)

Format : Webconférence interactive BigBlueButton (Atelier clinique d'analyse de situations réelles)

Durée analysée : 2 h 08 min (séance intégrale)

1. Fiche Synthétique « L'Essentiel du Cours »

🎯 **FIL CONDUCTEUR FONDAMENTAL**

« Le collectif de travail n'est ni une somme d'individus ni une équipe prescrite : il est un espace vivant de délibération sur le travail bien fait qui sédimente et renouvelle le genre professionnel face aux impasses du réel. » La santé au travail repose sur la possibilité pour les travailleurs de développer des catachrèses créatives, de s'adosser à des règles de métier incorporées et de bénéficier d'espaces institutionnels d'Analyse des Pratiques (APP), à l'opposé des dérives du coaching managérial qui isole et culpabilise l'individu.

🧠 CE QU'IL FAUT SAVOIR (THÉORIE & CLINIQUE)

- **La Catachrèse (Rabardel / Clot) :** Détournement créatif d'un outil ou d'un dispositif prescrit pour répondre aux contraintes et urgences du travail réel (ex. utiliser une aide à la recherche pour financer l'aménagement ergonomique d'une assistante maternelle sans médecin du travail).
- **Collectif de crise vs Collectif pérenne :** Savoir coopérer dans l'urgence en « one-shot » (typique des soignants ou crèches en sous-effectif) ne suffit pas à créer un collectif de travail viable s'il repose uniquement sur le sacrifice individuel et l'épuisement.
- **Genre vs Collectif de travail :** Le collectif de travail est l'instance vivante d'arbitrage et de confiance ; le genre professionnel est le réservoir impersonnel et historique des règles de métier qui s'épaissit ou s'étiole selon la qualité du dialogue.
- **Critique radicale du coaching d'entreprise :** L'injonction néolibérale (« soyez auteur de votre vie et pas acteur ») individualise la souffrance et culpabilise l'agent face à des dysfonctionnements organisationnels et structurels (compétition, objectifs intenables).

🎓 CE QU'IL FAUT RETENIR (COPIE D'EXAMEN CNAM)

- **Caroly & Clot (2004) — Les facteurs de renouvellement du genre :** Tolérance managériale (laisser une marge de manœuvre sans exiger une formalisation étouffante) vs Rétention et travail « sous le manteau » des anciennes qui bloque la transmission aux nouvelles.
- **Solidarité compassionnelle vs Coopération de métier :** Se soutenir moralement (« c'est dur, je compatis ») ne suffit pas : la santé clinique exige une coopération sur le geste technique et une dispute professionnelle sur les critères du travail bien fait.
- **L'appropriation du genre est un long cheminement :** Pour un nouvel arrivant, le genre ne se décrète pas par protocole ; il s'incorpore au contact des anciens dans un climat de sécurité psychologique.
- **Méthodologie d'intervention :** Refuser le simple groupe de parole cathartique ; déployer des méthodes d'accès au « côté obscur de l'activité » (instruction au sosie, auto-confrontation croisée) et mobiliser des indicateurs RH objectifs (turnover, absentéisme).

⚠️ **Le Piège d'Examen Impardonnable selon Mme Jessica Roussan :** 1) Croire qu'un collectif qui fait face à l'urgence (en se débrouillant seul sans moyens) est un collectif en bonne santé : c'est un collectif pompier qui s'épuise sur les personnes ; 2) Confondre solidarité relationnelle (affinités, réconfort) et collectif de travail (porté sur les règles de métier et la controverse) ; 3) Proposer un coaching individuel ou une formation en « gestion du stress » face à une mise en concurrence pathologique des salariés (se tromper de cible en psychologisant l'organisation).

2. Analyse Approfondie des 3 Cas Cliniques Réels Débattus en Séance

Cette séance interactive est dédiée à la confrontation des concepts fondamentaux de la Clinique de l'activité à trois situations réelles rapportées et problématisées par les auditeurs :

Cas 1 : L'Assistante Maternelle en Situation de Handicap & la Catachrèse de Dispositif (Karine & Stéphanie)

Situation clinique : Une chargée de maintien en emploi accompagne une assistante maternelle employée par des particuliers employeurs. Cette professionnelle présente un handicap et nécessite un aménagement matériel ergonomique lourd de son poste pour continuer à exercer.

L'impasse du prescrit : Les particuliers employeurs ne cotisent pas aux Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) ; il n'y a donc aucun médecin du travail rattaché. Or, le cahier des charges de l'AGEFIPH pour débloquer l'aide à l'adaptation impose formellement un avis médical d'aptitude aménagée délivré par le médecin du travail. En l'état du droit et des procédures, la salariée est condamnée à l'inaptitude et à la rupture d'emploi.

L'arbitrage de métier et la catachrèse : En concertation interne, l'équipe décide de mobiliser un autre dispositif : *l'aide à la recherche de solutions de maintien* (aide d'urgence exceptionnelle ne nécessitant pas d'avis médical initial). L'outil est délibérément détourné de son périmètre strict pour financer l'aménagement et sauver l'emploi.

Enseignements théoriques de Jessica Roussan :

- **La Catachrèse (Rabardel / Clot) :** Ce n'est pas une fraude malhonnête, mais un acte de compétence clinique : aller aux limites des outils pour répondre au travail réel et à la mission d'inclusion.
- **La tolérance hiérarchique :** La supérieure hiérarchique valide informellement (« oui super »). Cette tolérance managériale (ni procédure écrite rigide, ni interdiction) offre au collectif la marge de manœuvre nécessaire pour réguler les défaillances du système.
- **Du geste individuel au genre professionnel :** Pour que cette trouvaille ne reste pas un acte isolé, elle doit circuler de manière informelle mais partagée entre pairs (ex. collègues du département 64), participant à l'épaississement du genre professionnel des chargés de maintien.

Cas 2 : La Crèche en Sous-Effectif Dégradé : Réguler sans Réunion (Céline & Julie)

Situation clinique : Crèche municipale/communautaire organisée en 3 sections (bébés, moyens, grands) avec 2 agents par section. À 9h, une agente annonce son arrêt maladie pour 10h30. La directrice est absente (intérim sur un autre site). Le pool de remplacement est épuisé. Il reste 5 agentes pour gérer l'ensemble des enfants.

La régulation de l'activité en marche : Impossible de figer l'activité pour tenir une réunion formelle. Les agentes régulent dans l'action, par échanges furtifs deux par deux dans les couloirs ou la cour :

- Décalage des repas : les moyens mangent d'abord, les grands ensuite (gestion du niveau sonore et des crises).
- Annulation d'une réunion institutionnelle pour conserver les effectifs auprès des enfants.
- Négociation avec une jeune agente pour prolonger son temps de travail jusqu'à 18h face à l'urgence.

Enseignements théoriques de Jessica Roussan :

- **Le Genre comme mémoire vivante :** En l'absence de protocole écrit d'absentéisme, l'équipe s'appuie sur la mémoire historique incorporée du genre de métier, orientée par un critère cardinal partagé : *la sécurité et le bien-être des enfants*.
- **L'incorporation du genre chez la débutante :** La jeune agente hésite à rester. Elle se sent sous la pression du regard collectif (« comment vais-je être considérée si je ne reste pas ? »). Mme Roussan souligne que l'incorporation du genre est un long apprentissage qui ne peut s'opérer que dans un cadre sécurisant.
- **Spécificité de la clinique de l'activité :** L'ergonomie analyse l'objet et les flux physiques ; la clinique de l'activité explore *« le côté obscur de l'activité »*, ce qui se joue psychiquement dans l'empêchement, le doute et le conflit de critères, accessible par l'auto-confrontation croisée ou l'instruction au sosie.

Cas 3 : La Centrale d'Achat Carrefour : Compétition Féroce & Dérive du Coaching (Cécile & Mora)

Situation clinique : Une responsable encadre 10 approvisionneurs (agents de maîtrise) achetant du vin pour les hypermarchés Carrefour. L'organisation impose un indicateur unique et impitoyable : le *taux de service quotidien à 99%*.

La pathologie managériale : La direction orchestre une mise en concurrence délibérée des salariés (« il y a des bons, des moyens et des mauvais »). Les collègues se dénigrent sur le chat interne, s'insultent sur leur physique, refusent toute entraide de portefeuille. Le turnover est massif (départ tous les 2-3 ans, burn-out du manager précédent). Le genre professionnel est pulvérisé : personne ne reste assez longtemps pour s'approprier ou transmettre des règles de métier.

L'intervention du « Coach d'Entreprise » : Pour traiter la crise, la direction mandate un coach qui réalise des entretiens individuels en martelant : *« Soyez auteur de votre vie et pas acteur ! Ne subissez pas, assumez vos choix professionnels ! »*.

Critique radicale de Jessica Roussan :

- **Se tromper de cible :** Le coaching d'entreprise reporte la faute sur la fragilité de l'individu. C'est une dérive toxique qui masque une organisation pathogène par une injonction à l'adaptation personnelle.
- **L'inutilité du simple groupe de parole :** Un groupe de parole qui ne sert qu'à « vider son sac » (décharge émotionnelle) sans transformer le travail réel ne règle rien et accroît le sentiment d'impuissance.
- **L'intervention du psychologue du travail en clinique de l'activité :**
  1. Poser une problématique précise appuyée sur des **indicateurs RH objectifs** (taux de rotation, arrêts maladie, absentéisme).
  2. Ouvrir des espaces de controverse sur le travail réel (instruction au sosie, auto-confrontation croisée).
  3. Interroger la direction sur ses choix organisationnels (incompatibilité entre mise en concurrence et performance pérenne).
  4. Faire preuve d'humilité : agir sur les marges de manœuvre locales de l'équipe même si la stratégie financière du groupe résiste.

3. Confrontation Conceptuelle : Collectif de Travail vs Équipe Prescrite

Mme Roussan synthétise les critères distinctifs entre une simple juxtaposition de salariés et un collectif clinique de travail :

Critère d'Analyse	L'Équipe Prescrite / Collectif de Crise	Le Collectif de Travail Clinique (PST106)
Origine et Décret	Décrétée par l'organigramme formel (fiches de poste, planning, procédures d'urgence).	**Non décrétable :** Construction historique vivante issue de la coopération réelle.
Gestion de l'Urgence	Régulation en « one-shot » sur l'héroïsme et le sacrifice individuel (soignants, crèche dégradée).	Régulation durable étayée par une **organisation du travail protectrice**.
Nature du Lien	Solidarité compassionnelle (« je compatis avec ta souffrance ») ou rivalité feutrée.	**Coopération de métier :** Confiance, entraide technique et reconnaissance mutuelle (Damien Cru).
Rapport aux Conflits	Conflits étouffés, évitement ou dégénérescence en **conflits de personnes** (Carrefour).	**Dispute professionnelle réglée :** Controverse permanente sur les critères du travail bien fait (Clot).
Rapport au Genre	Règles de métier figées, transmises sous le manteau ou détruites par le turnover.	**Genre professionnel plastique :** Épaississement et renouvellement continu des règles par le débat.
Espaces Dédiés	Échanges informels sur « temps off » (pauses café, couloirs) perçus comme suspects par la direction.	**Espaces institués d'Analyse des Pratiques (APP) :** Délibération formelle sur le réel de l'activité.

4. L'Apport Majeur de Florentina Caroly & Yves Clot (2004) : La Poste

Le cours s'appuie directement sur le texte de référence de Florentina Caroly (2004) analysant les guichets de La Poste :

> *« Même confrontés à des conflits de valeurs et des contraintes gestionnaires identiques, deux collectifs de travail produisent des activités radicalement différentes selon la qualité de leur dialogue de métier et la tolérance de leur hiérarchie. » (Florentina Caroly)*

La confrontation des deux agences postales :

- **L'Agence de Province (Le genre vivant et transmissible) :** La hiérarchie adopte une attitude de tolérance bienveillante : elle ne bloque pas les micro-aménagements informels trouvés par les guichetiers pour concilier vente de produits financiers et accueil social des usagers précaires. Les anciennes transmettent leurs astuces de métier aux jeunes agents. Le genre professionnel s'épaissit et protège les individus de la souffrance éthique.
- **L'Agence de Banlieue (Le genre empêché et le travail sous le manteau) :** La pression managériale et la surveillance hiérarchique imposent un respect strict des procédures descendantes. Les guichetières chevronnées gardent leurs astuces « sous le manteau » par insécurité et refusent de les transmettre aux nouvelles. Le travail collectif se fracture, les jeunes sont abandonnés face aux incivilités et le genre s'étiole.

5. Posture du Psychologue du Travail & Rectifications d'Examen

A. Les 3 Clés Méthodologiques de l'Intervention Clinique

1. **Distinguer la méthode ergonomique de la méthode clinique :** L'ergonomie analyse l'activité sur l'objet technique, la posture et les flux physiques. La clinique de l'activité pénètre le vécu psychique, les drames intérieurs et les conflits de critères à travers des méthodologies indirectes (auto-confrontation simple et croisée, instruction au sosie).
2. **Refuser le coaching de développement personnel en entreprise :** Quand une direction demande d'apprendre aux salariés à « gérer leur stress » ou à « être auteur de leur vie », le psychologue refuse de psychologiser l'organisation. Il réoriente la mission vers l'analyse du système, de la charge et de la qualité empêchée.
3. **Construire la problématique à partir d'indicateurs RH :** Pour convaincre une direction générale, le praticien s'appuie sur des données incontestables : turnover des services, taux d'absentéisme, déclarations d'accidents de travail, fréquence des alertes du médecin du travail et du CSE.

B. Tableau des Rectifications d'Examen Cnam (Mme Jessica Roussan)

Sujet / Notion	Erreur Classique de Copie	Rectification Attendue au Cnam
La Catachrèse	La considérer comme une faute professionnelle, une négligence ou une infraction aux protocoles.	C'est une **régulation vitale de l'activité réelle** : le détournement créatif d'un outil par le travailleur pour pallier les défaillances du prescrit et accomplir la tâche.
Le Collectif de Crise	Affirmer qu'une équipe qui réussit à gérer une urgence en sous-effectif prouve l'existence d'un collectif solide.	Une gestion en « one-shot » masque souvent un **épuisement sacrificiel individuel**. Sans organisation protectrice et sans espaces d'APP dans la durée, l'équipe s'effondre.
Le Rôle du Coach	Valider l'approche du coaching invitant le salarié à « être auteur de sa vie et responsable de sa réussite ».	C'est une **dérive néolibérale coupable** qui individualise et psychologise des dysfonctionnements structurels créés par la mise en concurrence et les objectifs irréalistes.
La Solidarité d'Équipe	Confondre la bonne entente, l'amitié de bureau et la solidarité verbale avec un collectif de travail.	La solidarité verbale est compassionnelle. Le collectif de travail exige une **coopération sur le geste technique et une dispute réglée sur les règles de métier**.